

TEMA 3.19 • OBSTETRICIA

Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo

PERFIL EUNACOM 2.01.2.014
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo

Definición: Sangrado uterino > 20 semanas de gestación.

Causas: Solo dos — **placenta previa** y **desprendimiento prematuro de placenta normoinsera (DPPNI)**.

Enfoque Diagnóstico Inicial

- **Especuloscopia** → descartar sangrado vaginal/cervical (confirmar que es metrorragia uterina)
- **Monitorización fetal** → si sufrimiento fetal agudo: interrumpir por vía más expedita de inmediato
- **Ecografía** → diferencia placenta previa de DPPNI

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Excepción a pedir eco: Si la clínica es **categorica de DPPNI** → NO pedir eco, ir directo a **tacto vaginal** para determinar vía más expedita e interrumpir. El diagnóstico es clínico, no ecográfico en ese caso.
Tacto vaginal está contraindicado en placenta previa (riesgo de hemorragia masiva).

Diagnóstico Diferencial Clínico

TABLA 3.19.1: CARACTERÍSTICA VS PLACENTA PREVIA		
CARACTERÍSTICA	PLACENTA PREVIA	DPPNI
Color del sangrado	Rojo brillante	Oscuro (más tiempo en cavidad)
Dolor	Indoloro	Doloroso (contracciones)
Tono uterino	Normal	Hipertonía
Sufrimiento fetal	No (habitualmente)	Sí — feto pierde oxigenación

Manejo

Placenta Previa (sintomática)

- **Contraindicar tacto vaginal** - Estabilizar hemodinámicamente (transfusión si necesario) - **Cesárea urgente** si sangrado abundante o sufrimiento fetal - Si sangrado autolimitado, madre y feto estables, < 34 sem → conducta expectante + corticoides antenatales

DPPNI (sintomático)

- **Tacto vaginal** → determinar vía más expedita - **Interrumpir siempre** (fórceps si condiciones; cesárea si no) - Única excepción: sangrado mínimo autolimitado, madre y feto estables → observar

ROGAM

Si madre Rh negativo → ROGAM en todas las metrorragias de segunda mitad.

Complicaciones

TABLA 3.19.2: PLACENTA PREVIA VS DPPNI	
PLACENTA PREVIA	DPPNI
Shock hipovolémico	Shock hipovolémico
Acretismo placentario (FR: inserción baja)	CID (coagulación intravascular diseminada)
Prematurez	Asfixia neonatal

| — | Prematurez |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo: Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo Definición: Sangrado uterino > 20 ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Enfoque Diagnóstico Inicial
- Diagnóstico Diferencial Clínico
- Manejo
- Placenta Previa (sintomática)
- DPPNI (sintomático)
- Complicaciones
- Sangrado uterino > 20 semanas de gestación.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (METRORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO)**PREGUNTA 1**

En relación a Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo: Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo Definición: Sangrado uterino > 20 ... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Metrorragia de la Segunda Mitad del Embarazo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: METRORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

1. Especuloscopia → descartar sangrado vaginal/cervical (confirmar que es metrorragia uterina) 2. Monitorización fetal → si sufrimiento fetal agudo: interrumpir por vía más expedita de inmediato 3. Ecografía → diferencia placenta previa de DPPNI ::::warning Excepción a pedir eco: Si la clínica es categórica de DPPNI → NO pedir eco, ir directo a tacto vaginal para determinar vía más expedita e interrumpir. El diagnóstico es clínico, no ecográfico en ese caso.